



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ورده جمعه رمضان محمد

العنوان : عزبة حورين

الحي / المدينة : العياط

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 29504052201362 رقم التليفون : 01117134070

العمر (تاريخ الميلاد) : 05-04-1995 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب ويريدي خط الأول لعلاج حالات ثانويات / ارتجاع أورام الثدي [14129]

قسم العلاج :
الأورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ورده جمعه رمضان محمد National ID: 29504052201362	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Trastuzumab IV

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ورده
جمعه رمضان محمد
عزبة جورين-قرية جرزا
مركز العياط - الجيزة

١٩٩٥/٠٧/١٥ ٢٩٥٠٤٠٥٢٢٠١٣٦٢
IM1893957

٠١١٧٢٤٠٧
٠١٩٨١٥٩١٦

٢٠٢٠/٠٧ ٢٩٥٠٤٠٥٢٢٠١٣٦٢
ربة منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة
فايز محمد رضوان رضوان
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٧/١٥

١

Patient's Name: Warda Gomaa Ramadan Mohammed
Date: 2026-08-29
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

PLAIN RADIOGRAPHIC EXAMINATION OF CHEST REVEALED:

- Obliterated left costophrenic angle (pleural effusion?).
- Clear right costophrenic angle.

Patient's Name:

Warda Gomaa Ramadan Mohammed

Date:

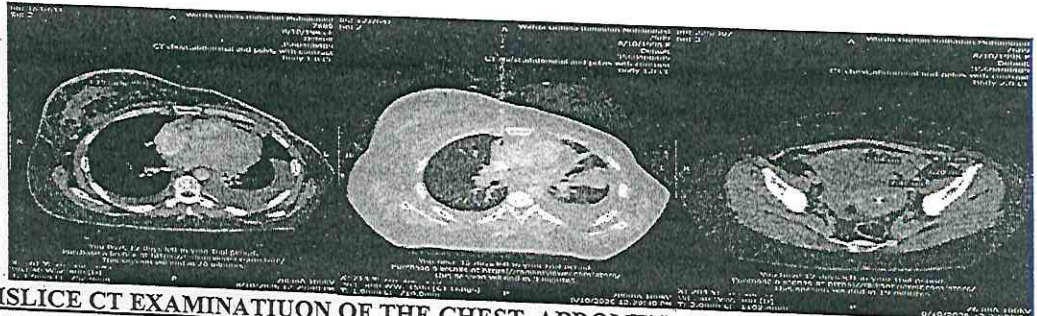
2026-08-10

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt



**MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST
ADMINISTRATION REVEALED:-**

- Evident left mastectomy with no evidences of either residual/recurrent neoplastic lesions seen at the operative bed.
- The skin overlying the right breast is diffusely thickened and reaches maximally to about 13mm.
- Benign-looking right axillary lymph nodes are seen with preserved their hilar fat contents with the largest one measures about 10 mm.
- Hyperinflated both lungs.
- Bilateral pleural effusions are seen, more on the left side with passive retraction of the underlying lungs towards the hila.
- A tiny subpleural nodule is seen in the anterior segment of right upper pulmonary lobe and measures about 7mm in diameter.
- Patchy areas of consolidations are seen in the lingula and in the anterior segment of both lower pulmonary lobes.
- No other sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules, other patchy areas of consolidations or foci of calcifications noted.
- No sizable abnormally-enhancing mediastinal or hilar lymph nodes seen.
- Patent central airways.
- Mild pericardial effusion.
- Average size of the heart with normal CT of its big vessels.
- Tiny ill-defined lytic lesions are seen scattering in the spine.
- Border line sized liver, measuring about 16.1 cm, showing a homogenous parenchymal attenuation and enhancement pattern.
- No sizable abnormally-enhancing focal lesions or dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen, measuring about 9.2 cm. No focal lesions seen inside.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, both suprarenal gland, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No intra-vesical stones, solid masses, wall thickening or diverticulosis seen.

Patient's Name: Warda Gomaa Ramadan Mohammed
Date: 2026-08-10
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Bilateral ovarian cyst are seen and each measures about 60x73mm and 42x22mm in dimensions respectively.
- IUCD is seen in the uterine cavity.
- The rest of the pelvic structures are unremarkable.

IMPRESSIONS:

- Evident left mastectomy with no evidences of either residual/recurrent neoplastic lesions seen at the operative bed.
- The skin overlying the right breast is diffusely thickened .
- Hyperinflated both lungs with bilateral pleural effusions ,more on the left side with passive retraction of the underlying lungs towards the hila a tiny subpleural nodule in the anterior segment of right upper pulmonary lobe , patchy areas of consolidations in the lingula and in the anterior segment of both lower pulmonary lobes and tiny ill-defined lytic lesions scattering in the spine, likely to be metastatic in nature.
- Mild pericardial effusion.
- Bilateral ovarian cyst, larger on the right side.
- For clinical check up.

Prof/Hanan El-Ahwal.

ECHOCARDIOGRAPHY CONCLUSION

- Left Ventricle: Dilated left ventricular internal dimensions. Increased LV end-systolic dimension. Mild eccentric left ventricular hypertrophy.
- LV Systolic Function: Normal global systolic function. EF approx 57% (M-Mode) / 50-55%% (Eyeball).
- Mild Global Hypokinesia.
- Diastolic Function: Grade II (Pseudonormal).
- Left Atrium: Mildly dilated left atrium.
- Aorta: Dilated aortic root.
- left side pleural effusion for ct correlation

SIGNATURE

CLINIC LOCATIONS & APPOINTMENTS

CLINIC 01		CLINIC 02	
عيادة بني سويف		لدة الواسطى	
ADDRESS اول طريق القيوم - نزلة كويري السادات - اتجاه الاثري - اعلى عيادات الحسين		ADDRESS دار الطب - بجوار مستشفى الواسطى المركزى	
APPOINTMENTS / TEL 01100380069		APPOINTMENTS / TEL 01127580623	

بن العيادات والحجز

لدة الواسطى

دار الطب - بجوار مستشفى الواسطى المركزى

ناتواتساب : 01127580623

DR. AHMED HAMEED EDREES

MSc of Cardiology - Al-Azhar University

د. أحمد حميد إدريس

ماجستير أمراض القلب و قسطرة القلب - جامعة الأزهر

MEDICAL AND ECHOCARDIOGRAPHY REPORT

PATIENT	وردة جمعة رمضان	DATE	2026-08-27
AGE / SEX	39 / Female	PATIENT ID	626515

PATIENT CLINICAL SNAPSHOT

LATEST DIAGNOSIS

HF WITH IMPROVED EF

COMPLAINTS

Complaint: • Dyspnea on exertion (NYHA III)
• Orthopnea & PND
• COUPHING

EXAMINATION

Vitals: BP: 120/80 mmHg | HR: 80 bpm

General Exam: • Conscious, alert and oriented.
• DININISHED AIR ENTRY ON LEFT SIDE TO MID LUNG

Cardiac Exam: • Normal S1 & S2, no murmurs.

PLAN & ORDERS

Provisional Diagnosis: HR WITH IMPROVED EF (DRUG - INDUCED)

Referrals: • Refer to Cardiothoracic Surgery

ECHOCARDIOGRAPHY FINDINGS

LVEDD:	56 mm	LVESD:	39 mm
IVSd:	11 mm	LVPWd:	11 mm
LV Mass:	249 g	RWT:	0.39
EF (M-Mode):	57 %	EF (Eye):	50-55 %
Asc Aorta:	35 mm	LA Diam:	43 mm
RV Basal:	36 mm	TAPSE:	25 mm
IVC Diam:	12 mm		

- Acoustic Window: Good.
- Rhythm: Regular (NSR).
- Left Ventricular Dimensions: Dilated left ventricular internal dimensions. Increased LV end-systolic dimension.
- Left Ventricular Wall Thickness: Mild eccentric left ventricular hypertrophy.
- Left Ventricular Systolic Function: Normal global systolic function EF approx 57% (M-Mode) / 50-55% (Eyeball).
- Regional Wall Motion:

Regional Wall Motion Abnormalities:

- Mild Global Hypokinesia

- Diast Function: Grade II (Pseudonormal).
- Left Atrium: Mildly dilated left atrium.
- Aorta: Dilated aortic root.
- Right Ventricular Dimensions: Normal dimensions.
- Right Ventricular Systolic Function: Normal right ventricular systolic function.
- Pulmonary Pressure: No echocardiographic evidence of pulmonary hypertension.
- Aortic Valve: Normal morphology. Structurally normal.
- Mitral Valve: Normal morphology. Structurally normal.
- Tricuspid Valve: Normal morphology with no significant stenosis or regurgitation.
- Pulmonary Valve: Normal morphology with no significant stenosis or regurgitation.
- Interatrial Septum: Intact.
- Interventricular Septum: Intact.
- Pericardium: Normal pericardial thickness without pericardial effusion.
- Intracardiac Masses / Devices: No additional masses, vegetations, thrombi, or cardiac devices seen.
- Additional Notes: left side pleural effusion for ct correlation

FINAL DIAGNOSIS

HF WITH IMPROVED EF

CLINIC LOCATIONS & APPOINTMENTS

CLINIC 01	عيادة بني سويف
ADDRESS	اول طريق القيوم - نزلة كوبري السادات - اتجاه الأزهرى - أعلى عيادات الحسين
APPOINTMENTS / TEL	01100380069

CLINIC 02	بن العيادات والحجز
ADDRESS	دار الطب - بجوار مستشفى الواسطي المركزي
APPOINTMENTS / TEL	01127580623 : ٠١١٢٧٥٨٠٦٢٣



El Safwa Lab
أختيارك الأفضل ..

معامل الصفوة

تحاليل الطبية وأبحاث الدم

PatientID : 652
Patient Name : ورده جمعه رمضان / مدام
Patient Sex : Female - 30 Years
Referred by :
PatientContract : individual
Requesting Date : 11:38:10 28/08/2026
Reporting Date : 11:39:38 28/08/2026
Sample taken : Sample took inside Lab

Complete Blood Count Report

Test Name	Result	Unit	Ref. Range
♦ Red cell count	4.0	$10^6/\text{cmm}$	3.8 - 5.2
♦ Haemoglobin	10.5*	g/dL	12 - 15
♦ Haematocrit (PCV)	31.4*	vol%	35 - 45
♦ MCV	78.5*	fl	80 - 97
♦ MCH	26.2*	pg	27 - 32
♦ MCHC	33.4	%	30 - 35
♦ Platelet count	174	$10^3/\text{cmm}$	150 - 450
♦ RDW	45.0	%	39 - 45
♦ White cell count	7.15	$10^3/\text{cmm}$	4 - 11

Differential white cell count

<u>Relative</u>			<u>Absolute</u>		
	<u>Result %</u>	<u>Normal</u>		<u>Result /cmm</u>	<u>Normal</u>
Bands	2	0 - 6			
Segmented	73				
♦ Neutrophils	75	37 - 75		5362	2000 - 7200
♦ Lymphocytes	20	20 - 45		1430*	1500 - 4500
♦ Monocytes	4	2 - 10		286	100 - 800
♦ Eosinophils	1	1 - 4		72	40 - 400
♦ Basophils	0	0 - 2		0	0 - 150

Comment : - RBCs show Microcytic Hypochromic Anemia .
- WBCs show Absolute Lymphopenia .
- PLTs are adeque in number and well aggregated .

جزا بجوار الوحدة الصحية

٠١١٠٠٩٢٩٣٧٢

٠١١٤٣٨٠٧٥٢٩

PatientID : 652 PatientContract : individual
Patient Name : ورده جمعه رمضان / مدام Requesting Date : 11:38:10 28/08/2026 م
Patient Sex : Female - 30 Years Reporting Date : 11:40:08 28/08/2026 م
Referred by : /د/ Sample taken : Sample took inside Lab

Laboratory Report

Test Name	Result	Unit	Reference Range
Liver Profile			
Total Bilirubin	0.87	mg/dl	Up to 1.0
SGPT - ALT	20	U/L	Up to 40
SGOT - AST	59*	U/L	Up to 40
Kidney Profile			
Serum Creatinine	0.69	mg/dl	0.5 - 1.4
Blood Urea	22	mg/dl	15 - 45

COMPLAINTS

Complaint: COUPHNG (DRY)

EXAMINATION

Vitals: BP: 120/80 mmHg | HR: 110 bpm

General Exam: • Conscious, alert and oriented.

• DINISHED AIR ENTRY ON LEFT SIDE TO MID LUNG

PLAN & ORDERS

General Plan & Notes:

INHALERS

LEFT LUNG ASPIRATION

IF COUPHNG NOT IMPROVED ASSESSMNT GEMCTABINE
INDUCED PNEUMONITIS /ILD SHOULD BE CONSIDERD

ECHOCARDIOGRAPHY FINDINGS

LVEDD:	56 mm	LVESD:	40 mm
IVSd:	11 mm	LVPWd:	11 mm
LV Mass:	249 g	RWT:	0.39
EF (M-Mode):	54 %	EF (Eye):	50-55% %
Asc Aorta:	35 mm	LA Diam:	43 mm
RV Basal:	36 mm	TAPSE:	25 mm
IVC Diam:	8 mm		
• Aconstic Window: Good.			
• Rhythm: Regular (NSR).			
• Left Ventricular Dimensions: Dilated left ventricular internal dimensions. Increased LV end-systolic dimension.			
• Left Ventricular Wall Thickness: Mild eccentric left ventricular hypertrophy.			
• Left Ventricular Systolic Function: Normal global systolic function EF approx 54% (M-Mode) / 50-55% (Eyeball).			
• Regional Wall Motion:			
• <u>Regional Wall Motion Abnormalities:</u>			
• <u>Mild Global Hypokinesia</u>			
• Diast Function: Grade II (Pseudonormal).			
• Left Atrium: Mildly dilated left atrium.			
• Aorta: Dilated aortic root.			
• Right Ventricular Dimensions: Normal dimensions.			
• Right Ventricular Systolic Function: Normal right ventricular systolic function.			
• Pulmonary Pressure: No echocardiographic evidence of pulmonary hypertension.			
• Aortic Valve: Normal morphology. Structurally normal.			
• Mitral Valve: Normal morphology. Structurally normal.			
• Tricuspid Valve: Normal morphology with no significant stenosis or regurgitation.			
• Pulmonary Valve: Normal morphology with no significant stenosis or regurgitation.			
• Interatrial Septum: Intact.			
• Interventricular Septum: Intact.			
• Pericardium: Normal pericardial thickness without pericardial effusion.			
• Intracardiac Masses / Devices: No additional masses, vegetations, thrombi, or cardiac devices seen.			
• Additional Notes: left side pleural effusion for ct correlation			

FINAL DIAGNOSIS

HF WITH IMPROVED EF

ECHOCARDIOGRAPHY CONCLUSION

- Left Ventricle: Dilated left ventricular internal dimensions. Increased LV end-systolic dimension. Mild eccentric left ventricular hypertrophy.
- LV Systolic Function: Normal global systolic function. EF approx 54% (M-Mode) / 50-55% (Eyeball).
- Mild Global Hypokinesia.
- Diastolic Function: Grade II (Pseudonormal).
- Left Atrium: Mildly dilated left atrium.
- Aorta: Dilated aortic root.
- left side pleural effusion for ct correlation